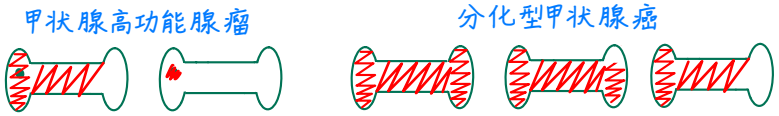
3.分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）



（1）切除范围

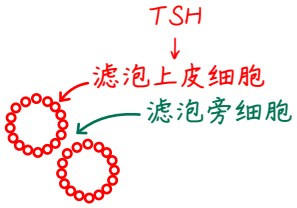
切除范围	指征
只要不满足<1和5个无 双侧**全切** 或**患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切** （满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌、有颈部放射史、预后不良的病理类型如高细胞型/柱状细胞型
患侧叶全切+峡部 病例题:只告诉<1cm,其他没说（全部满足）	肿瘤**＜1**cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型（＜1 和五个无）

注意：若肿瘤 1-4cm→充分评估是否有高危因素决定手术方式

（2）清扫淋巴结

①病灶同侧**中央区/VI/气管旁**淋巴结需**清扫**

②侧方淋巴结：**阴**性**不**清扫、**阳**性需**清扫**



髓样癌:来自于滤泡旁细胞
未分化癌:来自于滤泡上皮细胞,但没分化

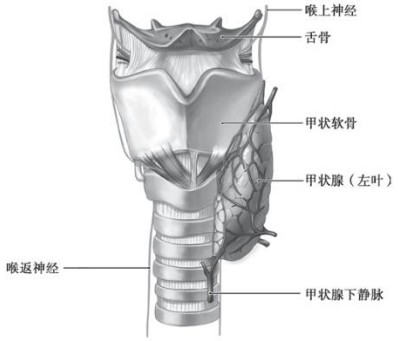


图 25-4　甲状腺腺叶(右)加峡部切除后示意图

（3）术后 给甲状腺素→抑制TSH(只与分化型甲状腺癌有关)

①**甲状腺素：预防甲减、防止复发** TSH会促进肿瘤生长

复发风险	抑制 TSH	一五得五、二五一十
高危	＜0.1	终生抑制
中危	0.1-0.5	终生抑制
低危	0.5-2	抑制 5-10 年、后改为替代治疗

②放射 ^{131}I 内放疗：术后残留组织摄碘率＞1%

③检测是否存在早期**复发**：**甲状腺球蛋白 TG**（用来合成甲状腺素的原料）
只是针对分化型甲状腺癌

	乳头癌	滤泡癌	髓样癌	未分化癌
TG	+	+	-	大多-
TTF	+	+	+	大多-
CT	-	-	+	-
Syn			+	

三、单纯性甲状腺肿/弥漫性非毒性甲状腺肿

①病因：缺碘、甲状腺素合成或分泌障碍、甲状腺素需求增多（青春期/妊娠等）负反馈TSH↑→甲状腺肿大

②甲状腺肿大：早期双侧弥漫肿大、后期少数可变为结甲（摸到结节）结甲前世:单纯性甲状腺肿

③治疗：甲状腺素

四、结节性甲状腺肿（前世今生）

eg.砂粒样钙化

结甲→胸骨后甲状腺肿、**继发甲亢**、**恶变**、退变（囊性变/片状钙化/纤维化）等 结甲今生

营养不良性钙化,偏向良性

囊性变伴囊内出血→结节迅速增大、胀痛

VS 甲状腺癌:迅速增大,不痛

五、亚急性甲状腺炎/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎

异物巨细胞见于:异甲虫
亚甲炎、慢性血吸虫的虫卵结节

①常有 **1-3 周前驱感染**（病毒感染等）

②甲状腺迅速肿大、**痛**：单侧或双侧不对称肿大、可摸到结节（先咽痛再脖子痛）

③部分滤泡被破坏（胶质外溢）→**分离现象：BMR/T_3/T_4↑、摄碘率↓**（部分滤泡被破坏）

④治疗：不进行治疗可致甲减→甲状腺素；NSAIDs 或糖皮质激素抗炎止痛。抗生素无效

1-3周前驱感染:病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎、IgA肾病(1-3天)